*SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MEDICILÂNDIA*

# *PLANO DE CONTINGÊNCIA MUNICIPAL DIANTE DA PANDEMIA DA DOENÇA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19)*

*GOVERNO "Com a Força do Povo"*

**MEDICILÂNDIA – PA**

**2020**

**PREFEITO DE MEDICILÂNDIA**

Celso Trzeciak

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Secretário: Danilo Lopes da Silva

**ELABORAÇÃO:**

Aurimar Dias dos S. Quixabeira – Coordenador de Vigilância Epidemiológica e Sanitária
Thais Couto de Camargo – Enfermeira/Vigilância em Saúde
Danilo Lopes da Silva – Secretário Municipal de Saúde de Medicilândia

**AGENTES DA VISA:**

José Luiz Campos Silva

Alexsandro Gomes Lopes

**Data da Elaboração**: Março de 2020

## SUMÁRIO

**1. INTRODUÇÃO..... 04**

**2. DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO..... 04**

**3. OBJETIVOS DO PLANO..... 05**

**4. NÍVEIS DE RESPOSTAS E RESPONSABILIDADES..... 05**

4.1 DEFINIÇÕES OPERACIONAIS..... **05**

4.2 NÍVEIS DE RESPOSTAS E RESPECTIVAS RESPONSABILIDADES..... **06**

**4.2.1 Nível de Resposta: Alerta..... 07**

**4.2.2 Nível de Resposta: Perigo Iminente..... 07**

**4.2.3 Nível de Resposta: Emergência de Saúde Pública (ESP)..... 10**

**5. MANEJO DOS CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS..... 13**

**6. REFERÊNCIAS..... 14**

## 1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta o Plano de Contingência Municipal para Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19) em caso de surto e define as responsabilidades e manejo do pacientes suspeitos e confirmados.

Em 29 de dezembro de 2019, um hospital em Wuhan admitiu quatro pessoas com pneumonia e reconheceu que as quatro haviam trabalhado no Mercado Atacadista de Frutos do Mar de Huanan. O hospital relatou essa ocorrência ao Centro de Controle de Doenças (CDC-China) e os epidemiologistas de campo da China (FETP-China) encontraram pacientes adicionais vinculados ao mercado e, em 30 de dezembro, as autoridades de saúde da província de Hubei notificaram esse cluster ao CDC da China. A partir desse momento, uma série de ações foram adotadas. O espectro clínico da infecção pelos coronavírus é muito amplo, podendo variar de um simples resfriado até uma pneumonia severa. No caso de infecção pelo 2019-nCoV, os dados mais atuais indicam sinais e sintomas respiratórios, principalmente febre, tosse e dificuldade para respirar.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou em 11 de março de 2020 que a doença pelo COVID-19 é uma pandemia, o que significa que o vírus está circulando em todos os continentes, sendo necessário atualizar as novas definições operacionais e reforçar a importância das medidas não farmacológicas, principalmente para as regiões que estão na estação chuvosa, em que há o aumento significativo dos casos de doenças de transmissão respiratória.

## 2. DIAGNÓSTICO EPIDEMIOLÓGICO

Com base no BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19 Nº 05/2020 Atualizado em 17/03/2020 e segundo relatório da OMS nº 56 (16/03/2020), foram registrados até o momento 167.515 casos confirmados e 6.606 óbitos de COVID-19 globalmente, com letalidade de 3,9%, onde 81.077 casos e 3.218 óbitos ocorreram na China, indicando uma letalidade de 3,9%. Os outros 86.438 casos estão distribuídos em 150 países/territórios/áreas com ocorrência de 3.388 óbitos e letalidade de 3,9%. A OMS avalia o risco do evento muito alto na China e muito alto nos níveis regional (Ásia) e global.

Foram registrados no Brasil, até 16 de março de 2020, 3.922 casos suspeitos de COVID-19, onde 2.064 estão em investigação, 1.624 já foram descartados e 234 casos foram confirmados, em 16 estados da federação. No Pará, temos 27 casos suspeitos, 24 casos descartados e até o momento não há casos confirmados. Na Data de 19/03/2020 o Pará confirma o primeiro caso da doença. A COVID-19 está registrada Classificação Internacional de Doenças 10ª revisão (CID-10) sob o código U07.1 (infecção respiratória pelo novo coronavírus).

Na data de 21 de março de 2020, em coletiva de imprensa, o Ministério da Saúde divulgou que, no Brasil, já são 1.128 casos confirmados de coronavírus, destes apenas 02 no estado do Pará e 18 mortes, concentradas nos estados de SP e RJ. O município de Medicilândia apresenta 01 caso suspeito, aguardando resultado de exame.

## 3. OBJETIVOS DO PLANO

Os objetivos deste Plano são:

I. Orientar a comunidade para manutenção de um ambiente seguro e saudável no contexto da Covid-19;

II. Reduzir o impacto da introdução e possível surto de 2019-nCoV no Município quanto a morbidade e mortalidade;

III. Otimizar os recursos existentes por meio de planejamento e programação de ações adequadas e oportunas aos objetivos.

## 4. NÍVEIS DE RESPOSTAS E RESPONSABILIDADES

### 4.1 DEFINIÇÕES OPERACIONAIS

**Caso suspeito de infecção humana pelo 2019-nCoV**

A priori, todo indivíduo com febre e sintomas respiratórios (tosse e dificuldade para respirar) E que nos últimos 14 dias, retornou de viagem internacional de qualquer país ou viagem nacional aos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, (apresentam transmissão comunitária) **OU** que nos últimos 14 dias antes do início dos sintomas tenha tido contato próximo com caso suspeito OU confirmado de 2019-nCoV. Porém, em 21 de março de 2020, o Ministério da Saúde anunciou uma mudança nos critérios de definição de caso suspeito, a partir de agora, também se enquadram as pessoas com sintomas (febre e

sinais respiratórios) provenientes de viagem nacional aos estados que apresentam transmissão comunitária.

**Caso confirmado de infecção humana pelo 2019-nCoV**

Indivíduo com confirmação laboratorial conclusiva para o 2019-nCoV, independente de sinais e sintomas.

**Caso descartado de infecção humana pelo 2019-nCoV**

Caso que não se enquadre na definição de suspeito e apresente resultado laboratorial negativo para 2019-nCoV **OU** confirmação laboratorial para outro agente etiológico.

**Caso Curado de COVID-19**

Segundo as definições do Ministério da Saúde, são curados:

Casos em isolamento domiciliar: Casos confirmados que passaram por 14 dias em isolamento domiciliar, a contar da data de início dos sintomas E que estão assintomáticos.

Casos em internação hospitalar: diante da avaliação médica.

Observação: a liberação do paciente deve ser definida de acordo com o Plano de Contingência local, a considerar a capacidade operacional, podendo ser realizada a partir de visita domiciliar ou remota (telefone ou telemedicina).

## 4.2 NÍVEIS DE RESPOSTAS E RESPECTIVAS RESPONSABILIDADES

Este plano é composto por três níveis de resposta: Alerta, Perigo Iminente e Emergência em Saúde Pública. Cada nível é baseado na avaliação do risco do novo Coronavírus afetar Medicilândia e o impacto na saúde pública. Questões importantes são consideradas nessa avaliação:

 Transmissibilidade da doença, como seu modo de transmissão, eficácia da transmissão entre reservatórios para humanos ou humano para humano, capacidade de sustentar o nível da comunidade e surtos;

 Propagação geográfica do coronavírus (2019-nCoV) entre humanos, animais, como a distribuição global das áreas afetadas, o volume de comércio e viagens entre as áreas afetadas e outras unidades federadas;

 Gravidade clínica da doença, como complicações graves, internações e mortes;

 Vulnerabilidade da população, incluindo imunidade pré-existente, grupos-alvo com maiores taxas de ataque ou maior risco de graves doenças;

 Disponibilidade de medidas preventivas, como vacinas e possíveis tratamentos;

 Recomendações da Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e evidências científicas publicadas em revistas científicas.

### 4.2.1 Nível de Resposta: Alerta

O Nível de resposta de Alerta corresponde a uma situação em que o risco de introdução do SARS-COV-2 seja elevado e não apresente casos suspeitos. No momento de elaboração do plano o município de Medicilândia não se enquadra mais nesta categoria, não havendo necessidade de elaborar medidas a uma etapa que não condiz à realidade.

### 4.2.2 Nível de Resposta: Perigo Iminente

Nível de resposta de Perigo Iminente corresponde a uma situação em que há confirmação de caso suspeito, conforme previsto no Capítulo IV, Seção I, Artigo 15 da Lei nº 8.080 de 19 de
setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências:

A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, as seguintes atribuições: XIII - para atendimento de necessidades coletivas, urgentes e transitórias, decorrentes de situações de perigo iminente, de calamidade pública ou de irrupção de epidemias, a autoridade competente da esfera administrativa correspondente poderá requisitar bens e serviços, tanto de pessoas naturais como de jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização.

O Município irá implantar a estrutura do Centro de Operações de Emergênciais para respostas ao 2019-nCoV (COE-nCoV) na vigilância em saúde, com órgãos e instituições que tenham relação com a resposta coordenada ao evento. Com a competência de detectar, investigar, manejar e notificar casos potencialmente suspeitos da infecção humana pelo novo coronavírus, estabelecer ações estratégicas que visam diminuir a disseminação do vírus e os impactos causados a população. Ações a serem realizadas pelos setores/instituições:

**I. Vigilância epidemiológica**

 Acompanhar a circulação/comportamento do 2019-nCoV no Brasil e no mundo;

 Monitorar e avaliar os casos suspeitos de 2019-nCoV no Município, informar o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS/PA) e realizar articulações necessárias para coleta de amostra;

 Monitorar disponibilidade de laudo no Gerenciamento de Ambiente laboratorial – GAL e intensificar a emissão de alertas sobre 2019-nCoV;

 Realizar reuniões técnicas presenciais com centros regionais e profissionais da secretaria de forma articulada e intersetorial;

 Participar de treinamentos sobre o 2019-nCoV e disseminar as informações e medidas estabelecidas (fluxos, protocolos e notas técnicas);

**II. Laboratório**

 Participar de treinamentos de coleta, armazenamento e envio de amostras (swab, bomba aspiradora, meio de cultura, máscara PFF2);

 Realizar a coleta e garantir o encaminhamento das amostras para o Laboratório de Referência Estadual – LACEN/PA;

**III. Assistência primária**

 Implementar as medidas de prevenção e controle de infecção pelos profissionais que atuam nos serviços de saúde para evitar ou reduzir ao máximo a transmissão de microrganismos durante qualquer assistência à saúde realizada. Executar os protocolos e fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-nCoV estabelecidos nacionalmente, para:

- Garantir a detecção oportuna de casos de síndrome gripal;
- Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e contatos, conforme exposição de caso;
- Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes suspeitos e profissionais que realizarem o atendimento, conforme estabelecido nos protocolos estabelecidos;
- Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;
- Avaliar o caso suspeito quanto à presença de sinais de gravidade e necessidade de hospitalização, conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus;

- Garantir o acompanhamento dos casos suspeitos leves e orientar quanto à instituição de medidas de precaução domiciliar, até o descarte por critério laboratorial;
- Direcionar o paciente com sinais de gravidade para os estabelecimentos de referência.

**IV. Urgência e Emergência/Unidades de Pronto Atendimento**

 Orientar os profissionais de saúde dos estabelecimentos de urgência e emergência e unidades de pronto atendimento quanto aos protocolos e fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-nCoV estabelecidos nacionalmente, para:

- Garantir a detecção oportuna de casos;
- Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e contatos, conforme definiçao de caso;
- Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes suspeitos, profissionais que realizarem o atendimento e os que realizarem procedimentos invasivos (intubação e coleta de amostra), conforme estabelecido nos protocolos estabelecidos;
- Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;
- Avaliar o caso suspeito quanto à presença de sinais de gravidade e necessidade de hospitalização, conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus;
- Garantir o acompanhamento dos casos suspeitos leves e orientar quanto à instituição de medidas de precaução domiciliar, até o descarte por critério laboratorial;
- Direcionar o paciente com sinais de gravidade para os estabelecimentos de referência estabelecidos pela Regulação/SESPA.

**V. Vigilância sanitária**

 Implementar as ações de monitoramento aos Estabelecimentos comerciais, para notificações e fiscalizações de cumprimentos de normas que visem a segurança da população;

 Programar intersetorialmente o processo de vistoria integrada para as conformidade aos protocolos específicos da segurança do paciente e controle de infecção hospitalar do 2019-nCoV;

 Emitir alertas e sensibilizar os profissionais de saúde atuante, quanto à detecção de casos suspeitos e ao cumprimento dos protocolos específicos;

 Integrar o COE-nCoV, participando das ações estratégicas de controle e vigilância epidemiológica aos cadastrados, confirmados e notificados.

**VI. Comunicação**

 Prestar informações precisas e oportunas para a população, com absoluta transparência, sempre alinhadas com a estratégia de comunicação da Secretaria de Vigilância em Saúde;

 Manter a população informada e evitar reações sociais contra os pacientes, motivadas pela desinformação;

 Monitorar boatos e mensagens em sites oficiais e não oficiais, além de redes sociais, respondendo quando necessário.

### 4.2.3 Nível de Resposta: Emergência de Saúde Pública (ESP)

Corresponde a uma situação em que há confirmação de transmissão local do primeiro caso de 2019-nCoV. Neste nível de resposta a estrutura do COE atingirá seu nível máximo e seu funcionamento poderá ser presencial se estendendo fora do horário comercial, feriados e finais de semana.

Ações a serem realizadas pelos setores/instituições:

**I. Vigilância epidemiológica**

 Acompanhar a circulação/comportamento do 2019-nCoV no Brasil e no mundo e promover ações de educação em saúde referente à promoção, prevenção e controle da infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

 Monitorar e avaliar os casos suspeitos e confirmados de 2019-nCoV no Município, informar o Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde Nacional (CIEVS/PA) e realizar articulações necessárias para coleta de amostra, resultado dos exames e fluxos de atendimentos;

 Realizar reuniões técnicas presenciais com centros regionais e profissionais da secretaria de forma articulada e intersetorial;

 Acompanhar as publicações de orientações, normas, rotinas, medidas de prevenção e tratamento. Disseminar as informações e medidas estabelecidas (fluxos, protocolos e notas técnicas);

**II. Laboratório**

 solicitar os insumos necessários para coleta, armazenamento e envio de amostras (swab, bomba aspiradora, meio de cultura, máscara PFF2);

 Monitorar disponibilidade de laudo no Gerenciamento de Ambiente laboratorial – GAL;

 Garantir o encaminhamento das amostras para o Laboratório de Referência Nacional.

 Solicitar testes rápidos e estabelecer fluxo e critérios para sua realização. Com objetivo de detecção precoce.

**III. Assistência primária**

 Orientar os profissionais de saúde dos estabelecimentos de atenção primária quanto aos protocolos e fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-nCoV estabelecidos nacionalmente, para:

- Organizar os atendimentos das Unidades, para minimizar os riscos de transmissão, conforme protocolos do Ministério da Saúde. Visando a biossegurança dos usuários e profissionais;
- Estabelecer planos de ações de enfrentamento da pandemia nas Estratégias de Saúde da Família-ESF do município, coerentes com as diretrizes definidas pelo SMS, elaboradas, por sua vez, de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde-MS e Secretaria Estadual de Saúde-SESPA.
- A Atenção Primária de Saúde deve ser resolutiva para os casos leves. Devendo ser pactuados os fluxos, apoio diagnóstico e logístico na rede de atenção a continuidade do cuidado de usuários com maior gravidade.
- Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem, contatos e fatores de riscos, conforme definição de caso e garantir a detecção oportuna;
- Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes suspeitos e profissionais que realizarem o atendimento, conforme estabelecido nos protocolos;
- Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;
- Avaliar o caso suspeito quanto à presença de sinais de gravidade e necessidade de hospitalização, conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus;

- Garantir o acompanhamento dos casos suspeitos e confirmados leves e orientar quanto à instituição de medidas de precaução domiciliar;
- Garantir o monitoramento dos contatos de casos confirmados até o fim do período de incubação da infecção humana por 2019-nCoV;
- Direcionar o paciente com sinais de gravidade para os estabelecimentos de referência.

**IV. Urgência e Emergência/Unidades de Pronto Atendimento**

 Orientar os profissionais de saúde dos estabelecimentos de urgência e emergência e unidades de pronto atendimento quanto aos protocolos e fluxos estabelecidos para o atendimento, manejo e vigilância epidemiológica do 2019-nCoV estabelecidos nacionalmente, para:

- Garantir atendimento e detecção oportuna de casos. Organizar fluxos de todos os atendimentos realizados pelo setor, visando a biossegurança do usuário e profissionais de saúde;
- Avaliar todo caso de síndrome gripal quanto ao histórico de viagem e contatos, conforme definição de caso;
- Garantir o uso de equipamentos de proteção individual (EPI) pelos pacientes suspeitos, profissionais que realizarem o atendimento e os que realizarem procedimentos invasivos (intubação e coleta de amostra), conforme estabelecido nos protocolos estabelecidos;
- Notificar imediatamente a vigilância epidemiológica municipal;
- Avaliar o caso suspeito quanto à presença de sinais de gravidade e necessidade de hospitalização, conforme Protocolo de Manejo Clínico para o Novo Coronavírus;
- Garantir o acompanhamento dos casos suspeitos e confirmados leves e orientar quanto à instituição de medidas de precaução domiciliar;
- Garantir o monitoramento dos contatos de casos confirmados até o fim do período de incubação da infecção humana por 2019-nCoV;
- Direcionar o paciente com sinais de gravidade para os estabelecimentos de referência.

**V. Vigilância sanitária**

 Implementar as ações de monitoramento aos Estabelecimentos comerciais, para notificações e fiscalizações de cumprimentos de normas que visem a segurança da população;

 Programar intersetorialmente o processo de vistoria integrada para as conformidade aos protocolos específicos da segurança do paciente e controle de infecção hospitalar do 2019-nCoV;

 Emitir alertas e sensibilizar os profissionais de saúde atuante, quanto à detecção de casos suspeitos e confirmados ao cumprimento dos protocolos específicos;

 Integrar o COE-nCoV, participando das ações estratégicas de controle e vigilância epidemiológica aos casos cadastrados, confirmados e notificados.

**VI. Comunicação**

 Prestar informações precisas e oportunas para a população, com absoluta transparência, sempre alinhadas com a estratégia de comunicação da Secretaria de Vigilância em Saúde;

 Manter a população informada e evitar reações sociais contra os pacientes, motivadas pela desinformação;

 Monitorar boatos e mensagens em sites oficiais e não oficiais, além de redes sociais, respondendo quando necessário.

## 5. MANEJO DOS CASOS SUSPEITOS E CONFIRMADOS

Realizar alinhamento para toda a equipe sobre a pandemia:

 Infecção pelo Coronavírus: casos suspeitos, confirmados e descartados; transmissão; período de incubação e manifestações clínicas; exame confirmatório; notificação;

 Planejamento das ações locais, monitoramento clínico e estabelecer fluxo de atendimento para abordagem de usuários, conforme protocolo de manejo clínico do paciente suspeito e/ou confirmado para infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19). do MS;

 Medidas de prevenção pessoal e comunitária; Cuidados para o manejo do usuário que é caso suspeito ou confirmado; Medidas de prevenção para o profissional de saúde; Esclarecimento de dúvidas, medos e mitos.

 Realizar atualização com todos os profissionais sobre a higiene de mãos, uso de EPIs e outras medidas protetivas. Toda a equipe deverá ser mobilizada para participar dos momentos de alinhamento e devem obedecer aos critérios de distanciamento, sendo realizados preferencialmente em local aberto e ventilado. Implementando precauções para gotículas/aerossóis em situações especiais no enfrentamento de casos de infecção humana pelo novo coronavírus (COVID-19

 Desenhar o fluxo de atendimento para abordagem de usuários com Síndrome Gripal e suspeita de COVID19, revisando e adequando todas as regras de funcionamento da unidade para priorização das medidas de enfrentamento da epidemia.

 Estabelecer medidas protetivas para o idoso e grupos de riscos, conforme MS;

 Estimular a articulação da rede de urgência e emergência, rede hospitalar e laboratorial (públicos e privados) para encaminhamentos aos hospitais de referência de leitos de internação com isolamento e leitos de UTI com isolamento para casos graves, conforme fluxo estabelecido pela SESPA.

## REFERÊNCIAS

Agência Nacional de Vigilância Sanitária – http://portal.anvisa.gov.br/coronavirus

Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde – https://www.saude.gov.br/saude-dea-z/coronavirus